

Т3: Комплексные услуги в MedCRM

Версия: 3.0 Статус: для согласования с заказчиком Решение по учёту: **комплекс учитывается как одна услуга**

1. Зачем нужен модуль

Клинике нужно создавать **комплексные услуги** — готовые пакеты из нескольких обычных услуг прайса, которые продаются пациенту как одна услуга по одной цене.

Примеры:

- **Базовый женский чекап:** консультация + анализы + УЗИ.
- **Мужской чекап:** консультация + лабораторные исследования + ЭКГ.
- **Комплексная чистка зубов:** несколько стоматологических процедур в одном предложении.

Комплекс может включать услуги из разных направлений: консультации, лаборатория, УЗИ, стоматология и т.д.

2. Как это должно выглядеть для клиники

Администратор в справочнике услуг создаёт новую позицию типа **«Комплексная услуга»**.

У комплекса есть:

- название;
- категория, например «Чекапы» или «Комплексные услуги»;
- итоговая цена для пациента;
- состав: список услуг, входящих в пакет;
- количество по каждой услуге;
- возможность включить/отключить комплекс.

На примере скриншота:

e yd

апи

- консультация первичная;
- мазок на степень чистоты;
- микрореакция;
- общий анализ крови;
- УЗИ органов малого таза.

Комплекс продаётся и учитывается как одна услуга.

Что это значит:

- в записи, плане лечения, оплате и отчётах комплекс проходит как одна позиция;
- выручка считается по цене комплекса;
- депозит применяется к цене комплекса;
- статистика источников обращений считает сумму комплекса целиком;

- зарплата врача считается по комплексу как по одной услуге;
- входящие услуги показываются как справочная информация «Что входит», но не создают отдельные строки учёта.

Например, если «Базовый женский чекап» стоит 20 000 ₮, то в отчётах будет одна услуга:

Базовый женский чекап — 20 000 ₮

А не пять отдельных строк по анализам и консультациям.

4. Как это ложится на текущую архитектуру MedCRM

Текущая система уже подходит под такой вариант, потому что в ней есть три нужных слоя.

4.1. Справочник услуг

В MedCRM уже есть справочник ценовых услуг. В нём хранятся обычные услуги: название, категория, цена, единица измерения, материалы, активность и другие параметры.

Комплексная услуга должна храниться там же, как отдельная позиция прайса, но с признаком, что это пакет, и со списком входящих услуг.

Почему так правильно:

- не нужно заводить отдельный параллельный справочник;
- комплекс можно искать и выбирать там же, где обычные услуги;
- существующие формы выбора услуг смогут использовать тот же источник данных;
- импорт обычного прайса не ломается.

4.2. План лечения

В текущей архитектуре план лечения уже хранит список услуг и итоговую сумму.

Поэтому комплекс в плане лечения должен попадать как одна строка:

- название комплекса;
- категория комплекса;
- цена комплекса;
- количество;
- итоговая сумма;
- состав комплекса для отображения.

План лечения не должен автоматически разворачивать комплекс на отдельные услуги, потому что выбран вариант «комплекс как одна услуга».

4.3. Запись на приём

В текущей архитектуре запись на приём хранит пациента, врача, кабинет, дату, время, цену, депозит и источник обращения. Запись не хранит список услуг как отдельную сущность.

Поэтому в первой версии комплекс используется в записи как единая причина/услуга с одной ценой. Если пациент записывается на «Базовый женский чекап», то запись получает цену комплекса, а состав показывается администратору как справка.

Важно: на скриншоте есть переключатель **«Создавать отдельные записи: Да/Нет»**. Для текущей версии MedCRM этот режим не входит в объём, потому что принято решение учитывать комплекс как одну услугу. Если включить отдельные записи, это уже другой сценарий: системе пришлось бы создавать несколько записей на разные услуги/кабинеты/врачей, а текущая модель записи на приём под это не рассчитана без отдельной доработки.

4.4. Отчёты и статистика

Текущие отчёты по услугам считают данные из планов лечения: название услуги, категорию, цену, сумму к оплате и оплату.

Так как комплекс попадёт в план лечения одной строкой, отчёты смогут учитывать его как обычную услугу:

- «Базовый женский чекап» попадёт в отчёт одной строкой;
- сумма будет равна цене комплекса;
- фильтр по категории сможет показывать комплексы в категории «Чекапы»;
- детализация по пациентам будет показывать пациентов, которым назначен этот комплекс.

4.5. CRM и источники обращений

В текущей архитектуре CRM получает выручку из планов лечения и оплат пациента.

Если комплекс учитывается как одна услуга, источники обращений продолжают работать без изменений:

- лид приходит из источника;
- пациент получает план/услугу с комплексом;
- оплата комплекса увеличивает выручку пациента;
- источник обращения получает выручку по сумме комплекса.

Отдельно распределять выручку по внутренним компонентам комплекса не нужно.

5. Workflow: создание комплекса

```
graph TD
    A[Администратор] --> B[Открывает справочник услуг]
    B --> C[Нажимает «Создать комплексную услугу»]
    C --> D[Заполняет название, категорию и цену]
    D --> E[Добавляет услуги, которые входят в комплекс]
    E --> F[Система показывает сумму входящих услуг]
    F --> G[Администратор сохраняет комплекс]
    G --> H[Комплекс появляется в общем списке услуг и в выборе услуг]
```

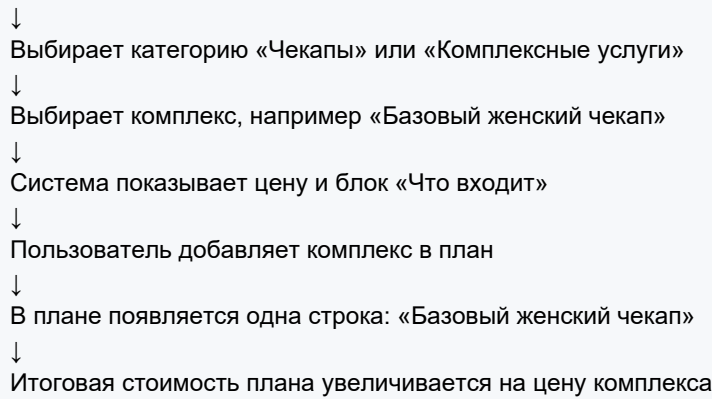
Что проверяет система при сохранении

Система не должна позволять сохранить комплекс, если:

- в составе есть отключённая услуга;
- в составе есть несуществующая услуга;
- в составе есть другой комплекс;
- комплекс пытается включить сам себя;
- не указана итоговая цена;
- не указано название.

6. Workflow: использование комплекса в плане лечения

```
graph TD
    A[Врач или администратор] --> B[Открывает карточку пациента / запись / план лечения]
```



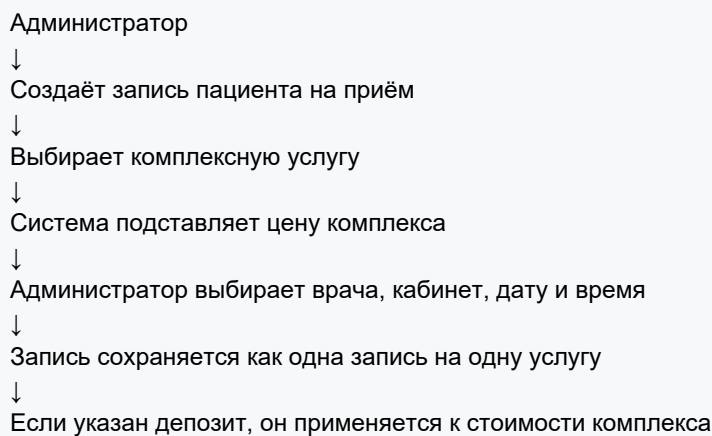
Что видит пользователь

В плане лечения пользователь видит:

- название комплекса;
- цену комплекса;
- количество;
- итоговую сумму;
- раскрываемый список «Что входит».

Внутренние услуги не создаются отдельными строками плана.

7. Workflow: запись пациента на комплекс

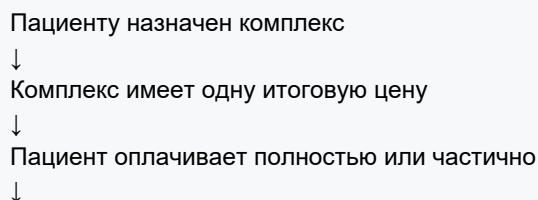


Важно по отдельным записям

Режим «создавать отдельные записи по каждой услуге комплекса» **не входит в первую версию**.

Причина: в текущей архитектуре запись на приём является одной сущностью с одной датой, одним временем, одним врачом, одним кабинетом и одной ценой. Автоматическое создание отдельных записей для компонентов потребует отдельной логики расписания, проверки конфликтов, врачей и кабинетов для каждой входящей услуги.

8. Workflow: оплата и отчёты



Оплата попадает в план лечения / запись

↓

CRM получает оплаченные суммы

↓

Отчёты показывают комплекс как одну оказанную услугу

Как комплекс попадёт в отчёты

В отчёте по услугам:

- услуга: «Базовый женский чекап»;
- категория: «Чекапы»;
- ожидаемая сумма: цена комплекса;
- оплаченная сумма: сумма оплаты по комплексу;
- количество: сколько раз комплекс был назначен.

В статистике источников:

- выручка источника увеличивается на сумму оплаченного комплекса;
- комплекс не разбивается по анализам, консультациям и УЗИ.

В зарплате врача:

- комплекс считается как одна услуга;
- если для комплекса задано правило оплаты врачу — используется оно;
- если правила нет, применяется текущая логика по существующим настройкам врача/услуг.

9. Что НЕ делаем в первой версии

Чтобы не усложнять запуск и не ломать текущую архитектуру, в первую версию не входят:

- автоматическое создание отдельных записей на каждую услугу комплекса;
- распределение цены комплекса между входящими услугами;
- отдельная зарплата по каждому компоненту комплекса;
- учёт материалов по каждому компоненту комплекса;
- вложенные комплексы, когда один комплекс содержит другой;
- автоматический пересчёт цены комплекса при изменении цены одной из входящих услуг.

Эти возможности можно вынести во вторую очередь, если заказчик подтвердит такую необходимость.

10. Границы изменения для существующей системы

Первая версия должна быть максимально безопасной для текущей CRM.

Что меняется:

- появляется тип услуги «комплексная услуга»;
- у услуги можно хранить состав;
- в интерфейсе выбора услуг можно раскрыть «Что входит»;
- в справочнике можно создать, изменить и отключить комплекс.

Что не меняется:

- существующие обычные услуги;
- текущая логика записи на приём;
- текущая логика плана лечения;

- текущий импорт прайса обычных услуг;
 - текущие отчёты по выручке;
 - текущая CRM-статистика источников;
 - текущая логика депозитов.
-

11. Сценарий для демонстрации заказчику

Пример: «Базовый женский чекап»

1. Администратор открывает справочник услуг.
 2. Создаёт комплексную услугу «Базовый женский чекап».
 3. Указывает цену: **20 000 ₴**.
 4. Добавляет состав:
 - консультация первичная — 1 шт.; - мазок на степень чистоты — 1 шт.; - микрореакция — 1 шт.; - общий анализ крови — 1 шт.; - УЗИ органов малого таза — 1 шт.
 5. Система показывает итог по составу и цену комплекса.
 6. Администратор сохраняет комплекс.
 7. В карточке пациента выбирает «Базовый женский чекап».
 8. В плане/записи появляется одна услуга на 20 000 ₴.
 9. Врач/администратор может раскрыть «Что входит».
 10. После оплаты комплекс отражается в отчётах как одна услуга.
-

12. Приёмка

Функционал считается готовым, если:

- можно создать комплексную услугу с названием, ценой, категорией и составом;
 - можно добавить в состав несколько обычных услуг из разных направлений;
 - система показывает итоговую сумму входящих услуг;
 - система показывает комплекс в выборе услуг;
 - при выборе комплекса видно «Что входит»;
 - комплекс добавляется в план лечения или запись как одна услуга;
 - цена комплекса участвует в итоговой сумме;
 - оплата комплекса отражается в отчётах и CRM-статистике как одна услуга;
 - нельзя добавить в состав отключённую, несуществующую или другую комплексную услугу;
 - существующие обычные услуги и импорт прайса продолжают работать как раньше.
-

13. Открытые вопросы для заказчика

1. Нужно ли показывать комплексы в онлайн-записи сразу или сначала только внутри CRM?
 2. Нужны ли отдельные права доступа: кто может создавать и менять комплексы?
 3. Цена комплекса должна вводиться вручную или по умолчанию предлагаться сумма входящих услуг?
 4. Нужно ли показывать пациенту экономию: «по отдельности X ₴, пакетом Y ₴»?
 5. Нужно ли печатать состав комплекса в документах/счёте или показывать только внутри CRM?
-

14. Резюме

Комплексные услуги внедряются как безопасное расширение текущего справочника услуг.

Для первой версии комплекс работает как одна продаваемая и учитываемая услуга. Это соответствует текущей архитектуре MedCRM: планы лечения и отчёты уже умеют работать со строками услуг и итоговыми суммами, а CRM уже получает выручку из планов и оплат.

Состав комплекса хранится и показывается пользователю, но не влияет на расчёты. Это позволяет быстро запустить функцию пакетов и чекапов без перестройки учёта, зарплат, источников и расписания.